الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

La pathologie vasculaire et les troubles circulatoires

Dr L.AMOUCHAS

Maitre Assistante en Anatomie et Cytologie Pathologique

CHU d'Oran

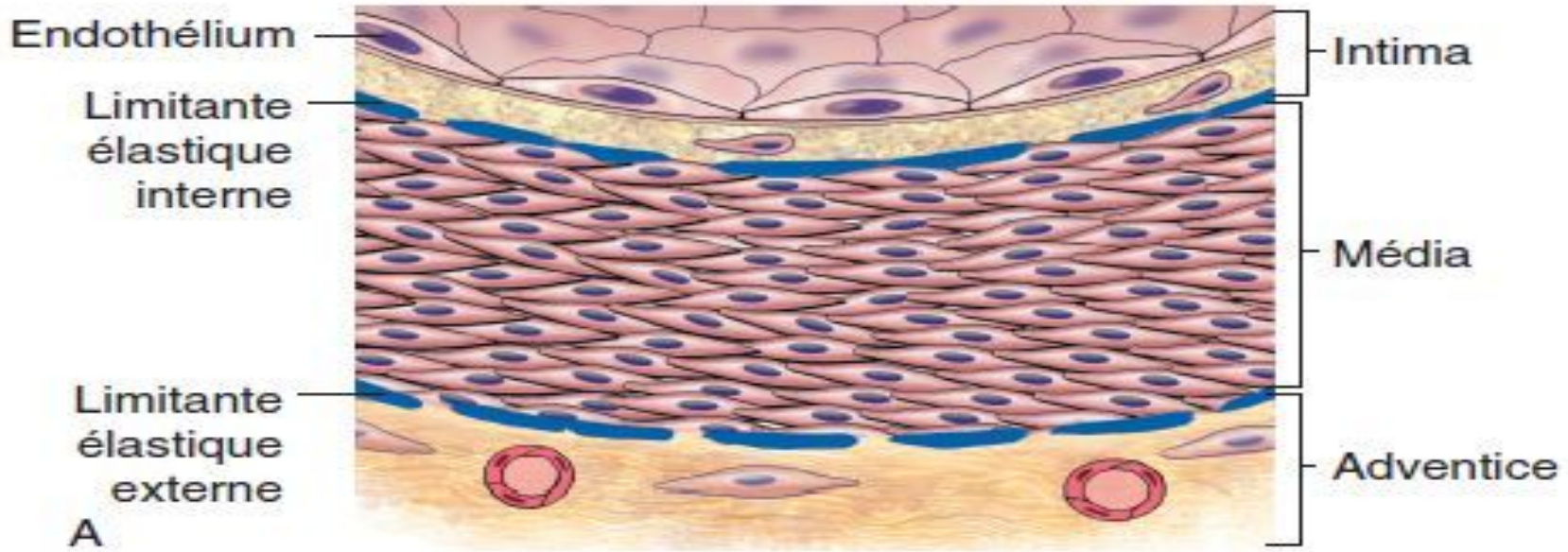
3 éme année médecine dentaire

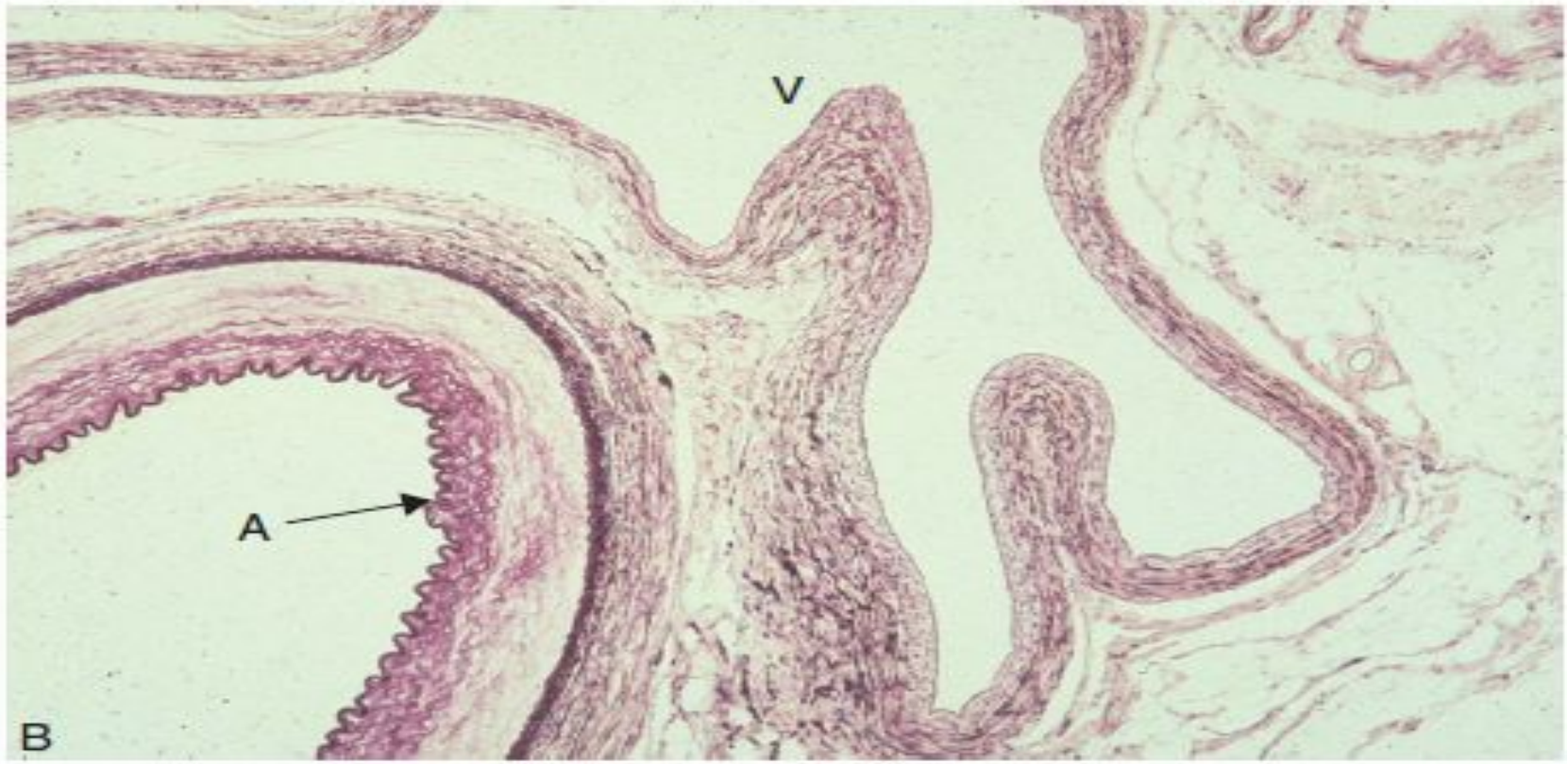
PLAN

I. INTRODUCTION
II. RAPPELS
III. OEDEME
IV. CONGESTION
V. HEMORRAGIE
VI. THROMBOSE
VII. EMBOLIE
VIII. ISCHEMIE INFARCTUS
IX. VASCULARITES

CONCLUSION

- **INTRODUCTION**
- La pathologie vasculaire occupe une place importante en anatomie pathologique.
- Lésion élémentaire (congestion œdème hémorragie)
- Troubles de la circulation sanguine (thrombose embolie infarctus)


Endothélium
Limitante élastique interne
Limitante élastique externe
Intima
Média
Adventice
A


V
A
B

1- Œdème

1.1 Définition : L'œdème est une augmentation de la quantité d'eau (les espaces Interstitiels) dans les espaces extravasculaires.

1.2 Aspect macroscopique :

-les tissus et organes œdémateux sont **mous et pâles** :

- après incision, ils peuvent laisser sourdre un écoulement de liquide légèrement rosé.

- Les œdèmes prédominent dans les parties déclives (œdèmes des chevilles).

- Le tissu garde parfois l'empreinte du doigt à la pression (signe du godet).

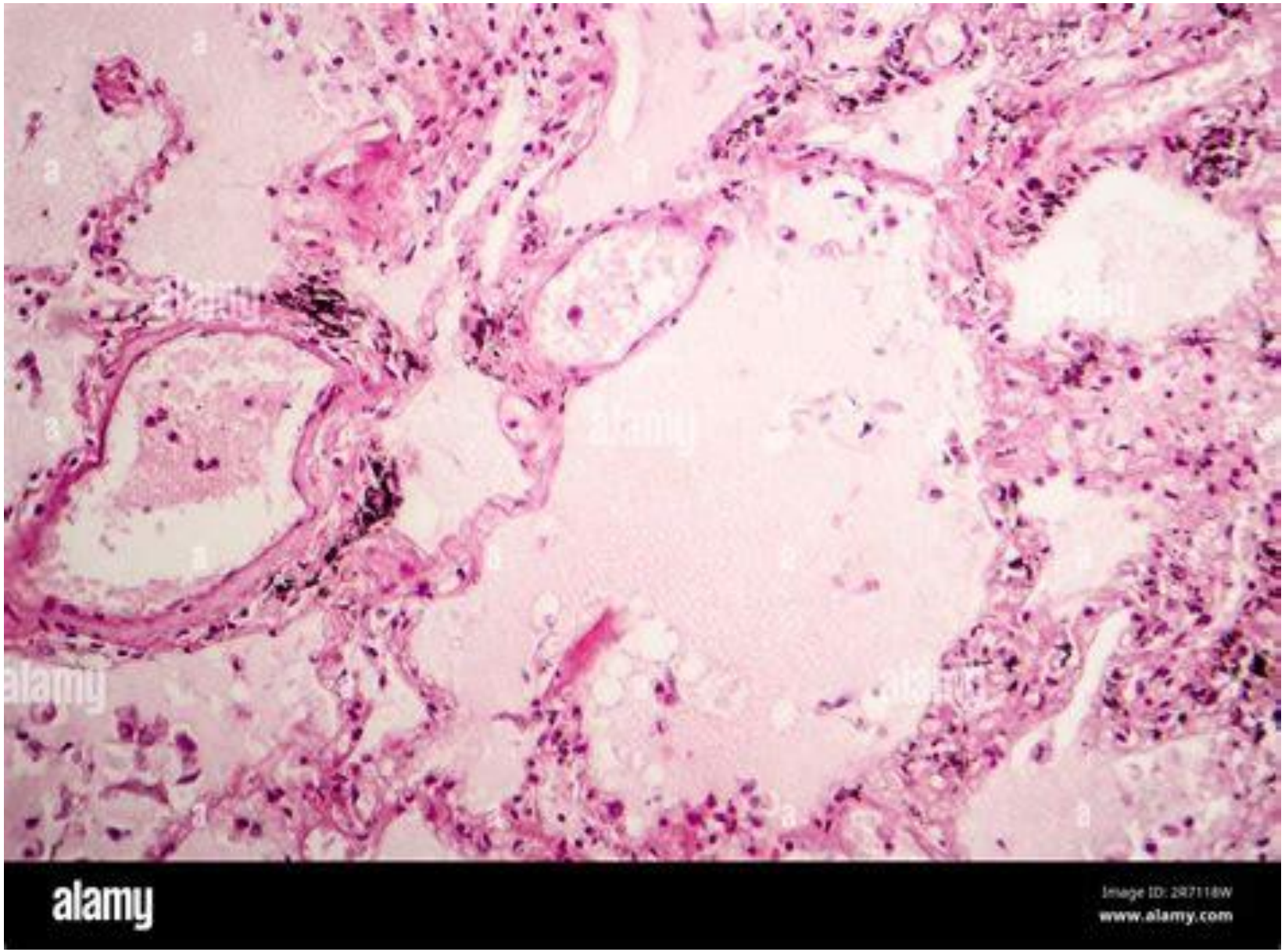
- L'œdème peut intéresser les cavités naturelles de l'organisme : séreuses (épanchement pleural, ascite), cavités articulaires (hydarthrose).

- L'anasarque désigne un œdème généralisé

1.3 Aspect microscopique :

Le tissu est infiltré par **une sérosité pâle, très faiblement éosinophile**, écartant les uns des autres les éléments constitutifs normaux (cellules, fibres).

Œdème pulmonaire



- **1.4 Physiopathologie des œdèmes :** On distingue deux types d'œdèmes :
- **Œdèmes hémodynamiques ou transsudats**. Pauvres en protéines plasmatiques, ils peuvent résulter de plusieurs mécanismes :
- augmentation de la pression hydrostatique dans le secteur veineux : soit œdème localisé par obstacle sur une veine, soit œdème généralisé par insuffisance cardiaque globale.
- diminution de la pression oncotique des protéines plasmatiques, dans tous les états d'hypoprotidémie (malnutrition sévère, protéinurie massive, insuffisance hépatique grave).
- obstacle au drainage lymphatique (éléphantiasis).
- rétention hydro-sodée (insuffisance rénale).

- **Œdèmes lésionnels ou exsudats**. Ils sont riches en protéines plasmatiques, et sont dus à une augmentation de la perméabilité endothéliale (phase initiale de l'inflammation). Exp : œdème lésionnel pulmonaire
- **1.5 Conséquences des œdèmes :** Varient selon le siège et l'intensité de l'œdème
- Mort subite possible en cas d'œdème aigu de la glotte, du poumon(OAP)
- Compression gênant le fonctionnement d'un organe : trouble de la fonction ventriculaire au cours des épanchements péricardiques (tamponnade cardiaque).
- Réaction inflammatoire et surinfection à la longue

2- La congestion

2.1 Définition : La congestion est une augmentation de la quantité de sang contenue dans des vaisseaux qui se dilatent.

2.2 Macroscopie : l'organe atteint est alourdi, tuméfié, de coloration rouge ou violacée (cyanose).

-A la coupe, le sang ruisselle en abondance.

-La congestion atteint surtout les organes riches en vaisseaux (foie, peau, glandes endocrines...).



Figure 04.03. Congestion : lumière veineuse distendue et emplie d'hématies. Flèche bleue : endothélium veineux. Étoile : hématies.

2.3 Microscopie :

- Les vaisseaux sont dilatés, bourrés d'hématies tassées les unes contre les autres.

-Les cellules endothéliales apparaissent turgescentes, faisant saillie dans la lumière vasculaire.

-2.4 Causes et mécanismes : deux types de congestion :

- **2.4a La congestion active :** Elle résulte d'une augmentation de l'apport de sang artériel : c'est une "hyperhémie artérielle par vasodilatation active". Elle peut être généralisée ou localisée.

- se traduit par une rougeur et une Chaleur locale

- Les organes touchés sont de poids augmenté

- **Cause :**
- - Mécanisme nerveux reflexe : rougeur de la face lors de l'émotion.
- - Adaptation lors d'une sollicitation fonctionnelle accrue (muscle en exercice).
- - Lors de la phase initiale d'une inflammation par la mise en jeu de médiateurs chimiques.

2.4b La congestion passive : Secondaire à la dilatation veineuse par diminution du drainage et obstacle à la circulation de retour.

-La congestion passive s'accompagne d'un ralentissement du courant sanguin appelé stase.

- **Aspect :** - Bleu violacée (Cyanose) avec un refroidissement local.

- Cause :

- • Locorégionales : varices, phlébites ou à une compression veineuse (dans la cirrhose du foie, hypertension portale, tumeurs)

-• Générales : insuffisance ventriculaire droite.

Exemples :

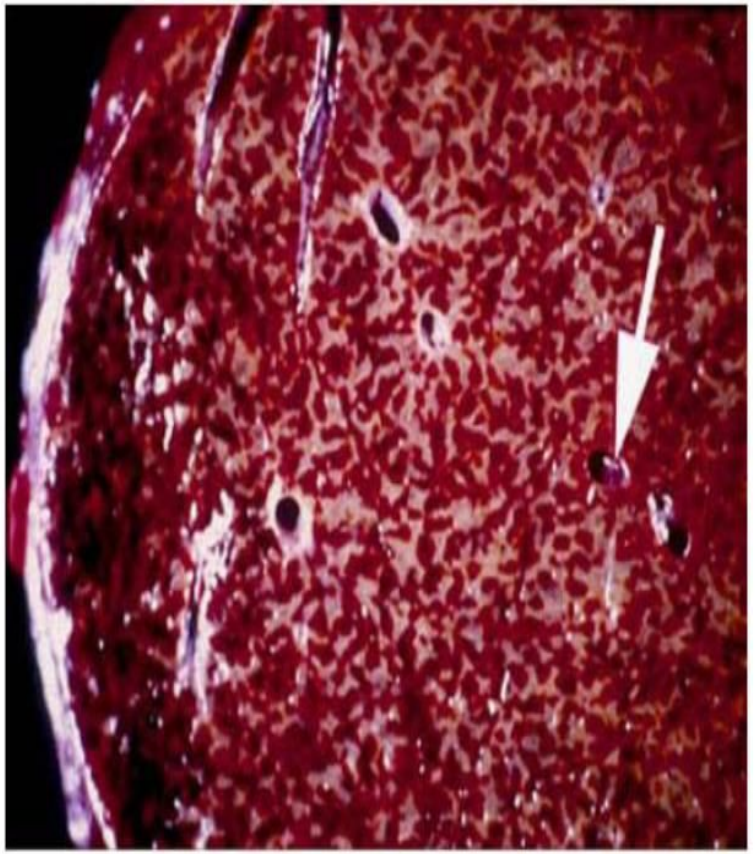
Le foie cardiaque : se voit dans l'insuffisance ventriculaire droite.

Macros : Le foie est gros, lisse et ferme, présentant à la coupe un aspect bigarrée l'aspect du foie "muscade".

Le poumon cardiaque : se voit dans l'insuffisance ventriculaire gauche.



Dossier n°1



Foie muscade

3- Les hémorragies

3.1 Définition : issue de sang hors des cavités vasculaires.

- Hémorragie artérielle : sang rouge vif, s'écoulant de manière saccadée
- Hémorragie veineuse : sang rouge sombre, s'écoulant de manière continue
- Hémorragie capillaire : en nappes (par érythrodiapédèse)

3.2 Causes :

3.2a Hémorragies par rupture vasculaire ou cardiaque : traumatisme externe, rupture d'une paroi fragilisée par une pathologie antérieure (anévrisme artériel), rupture du myocarde par nécrose ischémique (infarctus)

3.2b Hémorragies sans rupture vasculaire par érythro-diapédèse : lésions de l'endothélium par des toxines bactériennes (au cours de septicémies) ou à l'occasion de coagulopathies de consommation (lors de divers états de choc) ou au cours de certaines inflammations localisées

- **3.3 Types anatomiques des hémorragies** Les hémorragies peuvent être :
- **Extériorisées (externes) :** hématémèse, méléna, rectorragies, épistaxis, hémoptysie, plaie cutanée.
- **Collectées dans une cavité naturelle** (hémothorax, hémopéricarde, hémopéritoine….).
- **Intratissulaires :** hématomes (collection sanguine assez importante et bien limitée), hémorragie interstitielle (ecchymose, purpura, pétéchies).

3.4 Evolution des hémorragies

• Les hémorragies tissulaires peu étendues évoluent progressivement vers la résorption et la guérison, avec réaction inflammatoire et dégradation locale de l'hémoglobine : hémosidérine et autres pigments , expliquant le passage successif des ecchymoses par différentes couleurs). Les macrophages se chargent de pigment hémosidérinique (sidérophages).

• Si l'hémorragie, abondante, s'est accompagnée d'une nécrose tissulaire aboutissant à un tissu fibreux cicatriciel tatoué d'hémosidérine, parfois calcifié.

• En cas d'hématome volumineux, la détersion est souvent incomplète : il se produit alors un enkystement, on parle d'hématome enkysté.

- Dans une cavité séreuse, des dépôts de fibrine vont s’organiser en un tissu fibreux, épaississant les séreuses et ayant tendance à donner des adhérences ou des symphyses (accolement des feuillets viscéraux et pariétaux de la séreuse).

- **3.5 Conséquences :**
- Elles varient en fonction de leur importance et de leur siège.
- -Choc hypovolémique (hémorragie abondante et rapide).
- -Anémie ferriprive (hémorragies espacées dans le temps et lentes).
- -Destruction d'un tissu fonctionnellement vital pour l'organisme.
- -Compression gênant la fonction d'un viscère : hémopéricarde provoquant une insuffisance cardiaque aiguë (tamponnade).